

EPILEPSIE DE L'ENFANT

Questions de Résidanat septembre 2025

Cas clinique N°1 :

Nourrisson âgé de 5mois, ramené par ses parents pour exploration de mouvements anormaux répétitifs depuis 15jours, négligés et non explorés. Il n'a pas d'antécédents néonatalogiques particuliers. Son développement psychomoteur est normal avant l'installation de ces mouvements anormaux. A l'examen, le nourrisson est apyrétique et eutrophique. Il a une hypotonie axiale. Sa poursuite oculaire est non soutenue et il ne sourit plus. Il a de nombreuses tâches achromiques au niveau du tronc. Vous assistez à des contractures de tout le corps avec flexion des membres supérieurs. Les membres inférieurs se plient au moment de la crise avec un hochement de la tête. La crise est de durée de 10secondes et se termine par un cri.

1. Ce nourrisson présente :

- a. Des crises toniques
- b. Des crises autonomiques
- c. Des crises myoclonono-atonique
- d. Des spasmes épileptiques
- e. Des crises tonico-cloniques généralisées

2. En faveur d'un syndrome épileptique spécifique chez ce nourrisson, on retient :

- a. L'âge
- b. La sémiologie des crises
- c. La régression psychomotrice
- d. L'absence de microcéphalie
- e. Les tâches café au lait

3. Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demanderez-vous en première intention ?

- a. Les sérologies TORSH
- b. Un EEG
- c. Un scanner cérébral
- d. Un bilan thyroïdien
- e. Une IRM cérébrale

4. A l'EEG inter-critique, vous vous attendez à constater :

- a. Un tracé d'hypsarythmie
- b. Des pointes ondes à 4c/s
- c. Un rythme rapide frontal
- d. Une photosensibilité
- e. Des ondes lentes occipitales

5. Le traitement anti-épileptique, de 1^{ère} intention, à prescrire, est :

- a. Vigabatrin
- b. Valproate de sodium
- c. Topiramate
- d. Carbamazépine
- e. Phénobarbital

EPILEPSIE DE L'ENFANT

Cas clinique N°2 :

Patiente âgée de 6 ans, sans antécédents pathologiques notables, est ramenée par ses parents pour des épisodes au cours desquels, l'enfant semble être distraite en classe, ne répond pas à la maitresse tout en ayant le regard fixe, avec interruption brève de l'activité en cours. Ces épisodes sont pluriquotidiens et très brefs ne dépassant pas les 5 secondes. Après chaque épisode, l'enfant reprend son activité. L'examen neurologique ainsi que le développement psychomoteur sont normaux.

1- Quel diagnostic évoquez-vous devant ce tableau :

- a. Une épilepsie à paroxysmes rolandiques
- b. Une épilepsie lésionnelle
- c. Une épilepsie-absence de l'enfant
- d. Des troubles attentionnels
- e. Une épilepsie myoclonique juvénile

2- Vous demandez un EEG, quel (s) résultat (s) attendez-vous ?

- a. Un tracé de fond normal
- b. Des pointes frontales
- c. Des poly-pointes ondes généralisées
- d. Des pointes ondes généralisées à 3Hz
- e. Des ondes lentes amples postérieures

3- Parmi les traitements suivants, lesquels peuvent être prescrits selon le type de crises épileptiques que présente la patiente ?

- a. Le valproate de sodium
- b. La carbamazépine
- c. L'Ethosuximide
- d. Le Phénobarbital
- e. La Phénytoïne

4- A la consultation, vous pouvez reproduire une crise d'absence par :

- a. L'exposition à un stimulus thermique
- b. L'épreuve d'hyperventilation
- c. La pression des globes oculaires
- d. Le changement rapide de la position de la tête
- e. Une stimulation nociceptive

EPILEPSIE DE L'ENFANT

Cas clinique N°3 :

Enfant âgé de 14 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour des épisodes répétitifs décrits comme la sensation d'un inconfort digestif avec une sensation inexplicée de peur et une incapacité à parler durant 30 secondes. Son examen physique, en particulier, neurologique est normal.

1. **Selon la dernière classification de l'ILAE, ce patient présente des crises épileptiques de type ?**
 - a. Focal
 - b. Généralisé
 - c. Inconnue
 - d. Non classifié
 - e. Indéterminé
2. **Quel examen(s) complémentaire(s) demandez-vous ?**
 - a. Un EEG
 - b. Une IRM cérébrale
 - c. Un scanner cérébral
 - d. Un dosage des auto-anticorps anti-neuronaux
 - e. Un bilan thyroïdien
3. **Quels sont les éléments contre le diagnostic d'une épilepsie à paroxysmes rolandiques chez ce patient ?**
 - a. L'âge de survenue
 - b. La sémiologie des crises
 - c. La persistance des crises au-delà de l'adolescence
 - d. Les anomalies radiologiques à l'IRM cérébrale
 - e. Le développement psychomoteur antérieur normal
4. **Parmi les antiépileptiques suivants le (s) quel (s) choisissez-vous ?**
 - a. Diazépam
 - b. Clonazépam
 - c. Ethosuximide
 - d. Carbamazépine
 - e. Topiramate

Cas clinique N°4 :

Nourrisson âgé de 20 mois, sans antécédents notables, est ramené par ses parents aux urgences pédiatriques pour des clonies brèves des quatre membres durant 2mn. A l'examen, le nourrisson est apyrétique. L'examen neurologique est normal, ainsi que la glycémie capillaire. Les parents vous apprennent que cet épisode est survenu, à la crèche, à la suite d'une contrariété. Le patient a commencé à pleurer, puis sa respiration s'est bloquée brièvement et son visage est devenu de plus en plus cyanosé jusqu'à une perte de connaissance avec chute et survenue ultérieure des clonies des quatre membres. Il a présenté un épisode similaire, il y'a 2 mois, toujours précédé par une contrariété.

EPILEPSIE DE L'ENFANT

1- Quel diagnostic évoquez-vous devant ce tableau clinique ?

- a. Une hypoglycémie
- b. Une hémorragie cérébrale
- c. Une intoxication médicamenteuse
- d. Une méningo-encéphalite ourlienne
- e. Un spasme du sanglot

2- Quel est l'argument principal contre le diagnostic d'épilepsie chez ce nourrisson ?

- a. L'âge de survenue
- b. La perte de connaissance
- c. La cyanose du visage
- d. La notion d'un facteur déclenchant
- e. L'apyrexie

3- Les parents sont très inquiets, vous décidez ?

- a. De prescrire un anti épileptique d'épreuve
- b. De les rassurer
- c. D'hospitaliser le nourrisson
- d. De demander une IRM cérébrale
- e. D'administrer le Diazépam en intra rectal au besoin

Questions à choix multiples :

1. Le syndrome de West :

- a. Fait partie du syndrome des spasmes épileptiques du nourrisson
- b. Est une encéphalopathie épileptique du nourrisson âge dépendant
- c. Peut s'associer à une stagnation cognitive et motrice
- d. Survient avec un pic entre 12 et 18mois
- e. Est à l'origine d'une atteinte neurosensorielle irréversible

2. En faveur de spasmes de sanglot :

- a. Une tachycardie constante
- b. Une régression psychomotrice
- c. La notion de contrariété déclenchant les symptômes
- d. La séquence apnée-cyanose-perte de connaissance
- e. La persistance des symptômes au-delà de 5ans

3. Le syndrome de West peut compliquer l'évolution :

- a. D'une hypothyroïdie congénitale
- b. D'une méningo-encéphalite herpétique
- c. D'une encéphalopathie anoxo-ischémique
- d. D'une embryofetopathie à CMV
- e. D'une hémorragie cérébrale

EPILEPSIE DE L'ENFANT

4. **Selon la nouvelle classification 2025, les crises épileptiques peuvent être :**
 - a. Focales
 - b. Généralisée
 - c. Inconnues
 - d. Non classées
 - e. Partielles secondairement généralisées
5. **Une crise fébrile simple est caractérisée par :**
 - a. Son caractère focal
 - b. Sa durée brève
 - c. Un déficit post critique prolongé
 - d. La notion des antécédents familiaux d'épilepsie
 - e. La récurrence dans la journée
6. **Quel est le médicament aggravant les spasmes ?**
 - a. Le Topiramate
 - b. Le Valproate de sodium
 - c. L'ACTH
 - d. L'Hydrocortisone
 - e. La phénytoïne
7. **Quel est le principal effet indésirable du Vigabatrin (Sabril)**
 - a. Une perte de l'appétit
 - b. Une éruption cutanée
 - c. Une somnolence
 - d. Des nausées
 - e. Une constriction du champ visuel
8. **L'épilepsie à pointes Centro-temporales :**
 - a. Est une épilepsie focale
 - b. Est caractérisée par des crises oculogyres
 - c. Est associée à des troubles du comportement
 - d. Se complique fréquemment d'un état de mal épileptique
 - e. Est secondaire à une lésion temporale
9. **Le sommeil a un effet activateur des anomalies paroxystiques en cas :**
 - a. D'épilepsie à paroxysmes rolandiques
 - b. D'épilepsie absence de l'enfant
 - c. D'épilepsie séquellaire d'une hémorragie intra crânienne
 - d. D'épilepsie occipitale
 - e. De syndrome de spasmes épileptiques

EPILEPSIE DE L'ENFANT

10. Les crises typiques lors d'une EPR sont :

- a. Toniques
- b. Des crises hémi faciales se propageant au bras homolatéral
- c. Des absences avec myoclonies palpébrales
- d. Des crises myocloniques au réveil
- e. Des crises tonico-cloniques généralisées d'emblée

11. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) est nécessaire en cas :

- a. De spasmes épileptiques asymétriques
- b. De crises d'absences typiques
- c. D'anomalies focales à l'EEG
- d. D'un examen neurologique anormal
- e. De myoclonies de sommeil

12. Pour différentier entre une crise d'absence et une crise focale avec arrêt de l'activité, vous demandez en première intention :

- a. Une IRM cérébrale
- b. Un EEG inter critique
- c. Un EEG critique
- d. Un scanner cérébral injecté
- e. Un EEG du sommeil

13. Le Valium® :

- a. Est le traitement d'urgence en cas de crise épileptique
- b. S'administre en intra rectal
- c. Appartient à la famille des benzodiazépines
- d. Est un traitement anti épileptique au long cours
- e. Possède des effets indésirables respiratoires

14. Un traitement antiépileptique :

- a. Doit être instauré dès la première crise épileptique
- b. Doit être basé sur la balance bénéfice-risque
- c. Peut donner des interactions médicamenteuses avec certaines molécules
- d. Peut être limité par les effets indésirables
- e. Suit des protocoles dans certains syndromes épileptiques

EPILEPSIE DE L'ENFANT

- 15. Quels sont les effets indésirables attribuables à la Dépakine® ?**
- a. L'obésité
 - b. Le tremblement
 - c. La chute des cheveux
 - d. L'hypertrophie gingivale
 - e. La toxicité hépatique
- 16. Quels sont les médicaments indiqués en cas d'EMJ :**
- a. Le Lévétiracétam
 - b. La lamotrigine
 - c. Le valproate de sodium
 - d. La carbamazépine
 - e. Le vigabatrin
- 17. Quels sont les anti-épileptiques pourvoyeurs d'une dépression respiratoire ?**
- a. Le Lévétiracétam
 - b. Le Valproate de sodium
 - c. La Carbamazépine
 - d. Le Diazépam
 - e. Le Clonazépam
- 18. Une photosensibilité est fréquente, lorsqu'il s'agit :**
- a. D'un syndrome de West
 - b. D'un syndrome neuro-cutané
 - c. D'épilepsie à paroxysmes rolandiques
 - d. D'épilepsie myoclonique juvénile
 - e. D'épilepsie séquellaire d'une encéphalite herpétique
- 19. Les crises d'absences :**
- a. Sont des crises généralisées
 - b. Peuvent révéler un hamartome hypothalamique
 - c. Peuvent s'associer à une somnolence en post critique
 - d. Peuvent être associées à des myoclonies au cours d'une EMJ
 - e. Peuvent survenir au cours d'une manœuvre d'hyperventilation
- 20. Une épilepsie absence de l'enfant est caractérisée à sur le plan électrique par :**
- a. Un tracé de fond normal
 - b. Des pointes ondes focalisées
 - c. Des poly-pointes ondes de fréquence décroissante
 - d. Un début et une fin brutale des anomalies paroxystiques
 - e. Des ondes lentes delta diffuses

EPILEPSIE DE L'ENFANT

21. Les crises focales, de type cognitif peuvent se manifester par :

- a. Une déviation de la tête vers un côté
- b. Une impression de déjà-vu
- c. Des révulsions des globes oculaires
- d. Des accès de palpitations
- e. Des troubles du langage

22. En faveur de crises non épileptiques psychogènes, vous retenez :

- a. La notion de chutes traumatisantes
- b. La présence régulière d'un témoin
- c. L'association à une comorbidité psychiatrique
- d. La notion d'un conflit familial
- e. L'association fréquente à des signes végétatifs

23. Parmi les comorbidités fréquemment associées à l'épilepsie, vous retenez :

- a. Les troubles du sommeil
- b. Les troubles de l'appétit
- c. Les troubles d'apprentissage scolaire
- d. L'anxiété
- e. La déficience intellectuelle

24. Les crises qui se manifestent par une interruption brève et soudaine du tonus musculaire sont :

- a. Les crises atoniques
- b. Les crises myocloniques
- c. Les absences myocloniques
- d. Les absences atypiques
- e. Les crises cloniques

25. L'hirsutisme est un effet indésirable en rapport avec :

- a. Le Valproate de sodium
- b. Le Phénobarbital
- c. La phénytoïne
- d. Le diazépam
- e. La carbamazépine

EPILEPSIE DE L'ENFANT